

Une personne autiste en soutien intensif sous vos soins

Pour les médecins de famille, les médecins d'EHPAD et les cliniciens — soigner un adulte autiste en soins assistés / établissement résidentiel / soutien intensif (tout âge).

L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Pour une personne autiste en soutien intensif, les environnements de soins sont souvent les **plus difficiles de tous** : hostiles sur le plan sensoriel, perturbant les routines, riches en contacts physiques et en demandes imprévisibles. Beaucoup communiquent sans parole (CAA, comportement ou via un tiers de confiance) et peuvent ne pas enregistrer ou signaler la douleur avant qu'elle ne soit sévère. Le consentement, la capacité et la dignité reposent sur le fait de travailler *avec* l'attention, les routines et les personnes de confiance — ne jamais supposer une incapacité à partir d'une communication atypique.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous pouvez observer...	Ce qui se passe souvent
Détresse, auto-mutilation, « comportement difficile », refus	Écrasante majorité de communication sur un besoin non comblé — douleur, peur, surcharge sensorielle, perte de routine
Meltdown ou shutdown pendant les soins	Réponse involontaire du système nerveux à la surcharge — <i>pas</i> de l'agression ou de la non-observance
Ne signale pas la douleur ; effondrement soudain / présentation tardive	Différences d' intéroception — les signaux internes peuvent ne pas être enregistrés avant d'être sévères
Retrait lors de changements d'objets, d'ordre ou de personnel	Les routines et les possessions sont des ancres d'identité et de sécurité
Pas de parole fiable ; s'appuie sur la CAA, le comportement ou un accompagnateur	Communication atypique ≠ manque de capacité ou de compréhension

Essayez ceci

- **Bâissez les soins autour de la prévisibilité** : personnel constant, même séquence, supports visuels, préavis pour chaque changement.
- **Réduisez la charge sensorielle** — salle calme, lumière tamisée, réduction des bips et des odeurs fortes ; préservez les objets, intérêts et routines de la personne.
- **Recherchez la douleur et les causes physiques en premier** pour toute nouvelle détresse ou changement de comportement — la constipation, les douleurs dentaires, les infections ou un équipement mal ajusté sont des coupables courants et cachés.
- **Utilisez la prise de décision assistée** : expliquez de manière accessible et littérale ; laissez un temps de traitement ; consultez l'accompagnateur de confiance et tout profil de communication/avance.
- **Établissez un plan calme et écrit pour le meltdown/shutdown** : réduisez la stimulation, assurez la sécurité, donnez du temps et de l'espace — ne contenez pas et ne punissez pas.

Évitez ceci

- Étiqueter la détresse comme « comportementale » avant d'avoir exclu la douleur et la surcharge.
- Utiliser la contention ou la sédation comme première réponse au meltdown/shutdown.
- Supprimer des routines, des objets ou des intérêts « pour leur propre bien », ou supposer un manque de capacité à partir d'une communication atypique.

Quand chercher plus de soutien

Traitez toute **détresse nouvelle ou croissante** comme un signal d'alarme médical jusqu'à ce que la douleur, l'infection, la constipation, les problèmes dentaires et les causes sensorielles/environnementales soient exclus. Dépistez le **burnout autistique** sous charge chronique. Impliquez des **équipes spécialisées en autisme/handicap mental** et en orthophonie (CAA). Documentez un **profil sensoriel, de communication et d'aménagements raisonnables** individualisé et intégrez-le au plan de soins.

Note sur le genre

Les femmes en soutien intensif sont particulièrement sous-identifiées et mal servies ; leur détresse est encore plus souvent mal interprétée. Appliquez la même rigueur pour exclure la douleur et la surcharge, quel que soit le mode de présentation ou de communication.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — la brève sur le **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.5 & 4) plus le **Guide pour la famille** (Partie 5, maisons de retraite et hôpitaux). Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** À adapter à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interoception/pain); AASPIRE AHAT; Autism Society (2025, meltdowns/shutdowns); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.